Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Lajeado

Rua Paulo Frederico Schumacher, 77 - Bairro: Moinhos - CEP: 95900780 - Fone: (51) 309-85194 - Email: frlajeado1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5014706-21.2022.8.21.0017/RS

AUTOR: CAMILA ZANCO

RÉU: UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE ASSISTENCIA A SAUDE UNIMED E COOPERATIVAS DE MEDICOS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

CAMILA ZANCO, qualificada nos autos, ingressou com **AÇÃO COMINATÓRIA** contra **UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE UNIMED E COOPERATIVAS DE MEDIÇÕES UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.**, também qualificada. Narrou que apresentou melanoma de coroide no olho esquerdo, que trata-se de um tumor primário intra-ocular. Referiu que o tratamento utilizado pelo Dr. Hilton Medeiros é o laser ou a braquiterapia que consiste em aplicar radiação apenas no local do tumor. Após, foi submetida a avaliação do oftalmologista Dr. Diether Schmidt o qual indicou tratamento quimioterápico com anti-antigênico em caráter de urgência, com aplicação a cada 60 dias durante dois anos de EYLIA 40MG/ML. Contudo, refere que houve negativa de cobertura do tratamento pela requerida. Apontou que o tratamento é essencial para sua vida, correndo o risco de perder a cisão em detrimento da negativa. Ressaltou a previsão legal do medicamento oncológico pleiteado. Desse modo, requereu a procedência da demanda, juntando documentos (evento 01).

Recebida a inicial e deferida a tutela de urgência (evento 04).

Emenda a inicial (evento 15).

Recebida a emenda e deferida a alteração de dosagem do medicamento (evento 17).

Interposto embargos de declaração pela parte autora (evento 23), o qual foi acolhido (evento 30).

A Unimed apresentou contestação (evento 28). Aduziu que autora é beneficiária de contrato de assistência à saúde, na modalidade coletivo por adesão, firmado entre o SIMERS, e a requerida. Ressaltou que não autorizou o custeio em função do medicamento não estar de acordo com os requisitos técnicos e com as diretrizes de utilização previstas na DUT nº 74, Anexo II, da RN nº 465/2021, pela ANS. Pontuou que a autora é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão regulamentado, o qual se submete as disposições da Lei 9.656/98. Disse que para que houvesse o custeio pelo plano de saúde, a patologia da autora, melanoma de coroide, deveria constar na referida DUT. Discorreu que não existe eficácia científica comprovada para realização do exame pelo método escolhido pela autora, além de não haver, de igual modo, certeza inequívoca da amplitude dos efeitos colaterais que essa escolha pode ter a longo prazo. Ressaltou a inexistência de abusividade na e da taxatividade di Rol da ANS. Desse modo, requereu a procedência da demanda, juntando documentos.

Replicou a parte autora (evento 42).

Instadas as partes quanto as provas a produzir (evento 45).

As partes postularam o julgamento do feito (evento 53; 54).

Deferida a inversão do ônus da prova (evento 56).

É o relatório. Decido.

Tratando o feito de matéria exclusivamente de direito possível o conhecimento final da lide no estado em que se encontra nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

A ação procede. Dou as razões de decidir nesse sentido, fazendo parte integrante desta a decisão do evento 04 e 17, que concedeu a liminar que, em verdade, ora é ratificada.

De início, é preciso consignar que os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Aliás, sobre o tema em discussão o STJ editou a súmula n. 608, dispondo esta que: "*aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*

No caso dos autos, busca a autora, a cobertura de tratamento quimioterápico no uso do fármaco EYLIA 40mg/ml, nos moldes solicitados pelo médico assistente.

O melanoma do olho esquerdo evoluiu para maculopatia da radiação é necessário ser feito aplicações de injeção EYLIA TUSS 30307147 intervalo da injeção ocular a cada 30 a 45 dias com urgência.

Sendo necessário continuar as consultas periódicas com onco oftalmologista e clínico.

Cumpre salientar que embora o tratamento postulado não esteja expressamente previsto na Resolução Normativa nº428/2017 da ANS, ressalto que o rol de procedimentos publicado pela ANS constitui apenas uma referência de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência a saúde.

Sinale-se, ainda, que não há qualquer referência expressa no contrato entabulado entre as partes de exclusão de cobertura do tratamento postulado. Ora, as restrições de direito devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, o que não ocorreu no caso em tela, em afronta ao dever de informar consagrado na legislação consumerista. Ademais, que a vedação de cobertura não consta taxativamente no contrato, e cláusulas restritivas de direito não dão margem à interpretações extensivas.

Outrossim, que não cabe à requerida determinar ou limitar o tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha, que possui a capacidade de avaliar os riscos e benefícios para o quadro de saúde apresentado, indicando o tratamento mais indicado para o caso específico.

Nesse sentido, trago entendimento do e.TJRS em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA (CID C25). EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. COBERTURA DEVIDA Trata-se, consoante sumário relatório, de ação de obrigação de fazer, através da qual a autora busca cobertura do exame PET CT, porquanto acometida de câncer de pâncreas (CID C25), bem como indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem. Ao atender o comando do art.197 da Carta Constitucional, a Lei n. 9656/98, disciplinou os planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de complementar o Sistema Público Saúde (SUS). Com esse propósito foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), via Lei n.9961/00, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa. Nos termos da Súmula n.608/STJ, adequada à dicção do art.35-G da Lei n.9656/98, ficou expresso que o Código do Consumidor (CDC) tem aplicação subsidiária aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de saúde. Imprescindível considerar que afora a instituição do Plano-Referência de Assistência à Saúde, forte no art.10 da Lei n.9656/98, que garante o mínimo assistencial de caráter negocial privado, há, igualmente, a faculdade de o consumidor contratar plano de assistência à saúde de natureza superior e com maior cobertura, consoante faculta o art.12 do mesmo Diploma Legal. Ambos são regulados pela ANS, a diferença é o valor da contraprestação, o que infirma concluir que é inexorável considerar a natureza da negociação e a espécie de plano assistencial privado em litígio.O Plano de Referência estabelece exceções (art.10, incs.I a X, Lei n.9656/98), ou seja, hipóteses de não-cobertura, ressalvando-se a contratação facultativa complementar (art.12) e admissão por regulação da ANS (art.10,§1º), que poderá inclusive abranger transplantes e procedimentos de alta complexidade (art.10,§4º). Como consectário, não há como fugir do caráter limitador e taxativo do rol atualizado da ANS, agência reguladora, veiculado via Resoluções, sob pena de colocar em risco a saúde financeira e existencial dos próprios Planos Privados de Saúde.De acordo com o Anexo II, item nº 60, da Resolução Normativa nº 465/2021, da ANS, o exame de PET-CT Oncológico é de cobertura obrigatória para pacientes com câncer pulmonar de células não pequenas; linfoma; câncer colo retal; que necessitem de avaliação de nódulo pulmonar solitário; câncer de mama metastático; câncer de cabeça e pescoço; melanoma; câncer de esôfago localmente avançado; e tumores neuroendócrinos, de modo que a requerida embasa a negativa de cobertura no tipo de tumor apresentado pela autora - câncer de pâncreas. Sem razão a operadora, porquanto havendo previsão no rol da ANS a cobertura será devida pela operadora uma vez que incumbe, exclusivamente, ao médico que assiste ao paciente prescrever o tratamento de saúde que lhe é adequado, assim como a forma que este deverá ser prestado. Cobertura devida na integralidade. Descabida a indenização por danos morais, visto que ausente a recusa injustificada, que configura comportamento abusivo, capaz de ensejar a obrigação de reparar danos de ordem moral.DUPLA APELAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS(Apelação Cível, Nº 50025549120208210022, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-11-2022)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. IPE-SAÚDE. CÂNCER DE PELE. MELANOMA. TRATAMENTO. NECESSIDADE DE FÁRMACO. NEGATIVA DO INSTITUTO QUANTO POR NÃO CONSTAR NO PROTOCOLO ONCOLÓGICO. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS. 1. APELAÇÃO DO INSTITUTO 1.1 – O § 1º do art. 4º da LC-RS 15.145/2018, que revogou a LC 12.134/04, não pode ser interpretado de modo a esvaziar o caput. Não pode ser compreendido de modo a ensejar uma armadilha às garantias previstas no caput, mediante o artifício da delegação da cobertura pelo Sistema IPE-SAÚDE ao talante de quem faz a Tabela. Com efeito, o caput garante os atendimentos médico, hospitalar, ambulatorial e laboratorial, bem assim, relativamente a eles, garante os "atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários". A expressão "na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor", significa na maneira, no modo. Cuida-se de regra procedimental. Pode disciplinar a cobertura; não pode excluí-la. Assim sendo, quando o § 1º exclui da cobertura os procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais não previstos nas Tabelas, não se refere às garantias previstas no caput, sob pena de se consagrar uma cilada ao segurado. Refere-se, sim, a itens estranhos a tudo o que não diz respeito ao caput; e, no que este diz respeito (médico, hospital, ambulatório e laboratório), garante igualmente os atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos. 1.2 – Normalmente, nas ações que envolvem assistência à saúde, não há condenação do réu a pagamento, nem proveito econômico; logo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por "apreciação equitativa" (CPC, art. 85, § 8º). Caso de redução da verba fixada na sentença. 2. RECURSO ADESIVO DO AUTOR (DANOS MORAIS) Não é caso de dano moral in re ipsa, como ocorre nas situações das Súmulas 370, 388 e 403 do STJ, inclusive porque o Instituto negou o pedido baseado em norma interna. Ademais, o Instituto não pode ser obrigado a pagar danos morais pelos sofrimentos que a moléstia impõe ao paciente e aos familiares, nem pode sê-lo pelo fato de, no regular exercício do direito de defesa, entender que o Plano de Saúde não prevê a cobertura da pretensão do requerente, até porque, sendo o caso, pode ser reparado imediatamente em juízo por meio de tutela de urgência. 3. DISPOSITIVO APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50076659220208210010, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 16-11-2022)

Dessa forma, comprovada a enfermidade da parte autora (**LAUDO3**) a indicação do tratamento pelo médico assistente, o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS, bem como a imprescindibilidade do tratamento para a garantia do direito à saúde do paciente, a procedência do feito quanto ao tratamento é medida impositiva.

Por fim, ressalto que eventuais pedidos de ressarcimento de medicamentos deverão ser postulados em demanda própria.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, julgo **PROCEDENTE** a **AÇÃO COMINATÓRIA** ajuizada por **CAMILA ZANCO** contra **UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE UNIMED E COOPERATIVAS DE MÉDICOS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.,** todos qualificados, para o efeito, tornando **definitiva** a tutela de urgência deferida, **determinar** a requerida o fornecimento do tratamento quimioterápico - **uso do fármaco Eylia 40mg/ml**-, conforme indicação médica, enquanto perdurar a necessidade, pena de bloqueio de valores. **Condeno** a requerida ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao procurador da autora que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e segs., do CPC/2015.

P.R.I.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO DA SILVA CARVALHO, Juiz de Direito**, em 30/9/2024, às 14:44:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10066993374v9** e o código CRC **6f85dbaf**.